Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная **H91.1** — Пресбиакузис **H91.2** — Внезапная идиопатическая потеря слуха **H91.8** — Другие уточненные потери слуха
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/518_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Степени тугоухости 3

2.4 Другие классификации 4

2.5 Клиническая картина 4

2.6 Жалобы и анамнез 4

3. Диагностика 5

3.1 Физикальное обследование 5

3.2 Лабораторные исследования 5

3.3 Акуметрия 5

3.4 Тональная пороговая аудиометрия 6

3.5 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия 6

3.6 Речевая аудиометрия и объективные методы 6

3.7 Интерпретация аудиограммы 7

3.8 Вестибулометрия и лучевые методы исследования 7

3.9 Консультации и дифференциальная диагностика 7

4. Лечение и реабилитация 8

4.1 Внезапная и острая тугоухость 8

4.2 Хроническая тугоухость 8
4.3 Слухопротезирование 9
4.4 Кохлеарная имплантация 9
4.5 Показания к кохлеарной имплантации 9
4.6 Повторная имплантация 10
4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации 11
4.8 Санаторно-курортное лечение 12
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12
5.1 Показания к госпитализации 13
6. Источник и актуальность 13
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании жалоб, нормальной отоскопической картины и аудиологических данных: тимпанограмма типа «А», средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц составляет 26 дБ и выше, костно-воздушный интервал не превышает 10 дБ.
- Степень тугоухости определяется по среднему порогу воздушного звукопроведения на тех же четырёх частотах: I степень соответствует 26–40 дБ, II степень 41–55 дБ, III степень 56–70 дБ, IV степень 71–90 дБ, глухота 91 дБ и более.
- При внезапной и острой идиопатической потере слуха тональная аудиометрия проводится не позднее суток от момента первого обращения и повторяется перед выпиской для оценки эффективности лечения.
- Пациенты с острой сенсоневральной тугоухостью подлежат экстренной госпитализации в оториноларингологическое (или неврологическое) отделение; назначаются глюкокортикоиды по убывающей схеме.
- Подбор слухового аппарата показан при среднем пороге слышимости в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе 31 дБ и выше; при двусторонней тугоухости IV степени или глухоте показана кохлеарная имплантация.
- При хронической тугоухости пациент находится под наблюдением сурдолога-оториноларинголога; тональная и речевая аудиометрия повторяются 1–2 раза в год.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость (СНТ) характеризуется снижением слуха вплоть до его утраты вследствие поражения какого-либо участка звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Этиология и патогенез

Основным условием развития тугоухости является повреждение чувствительных структур улитки. Начальным звеном служит дистрофия волосковых клеток, которая при своевременно оказанной помощи может быть обратимой.

Причинами внезапной и острой СНТ являются инфекционные заболевания (грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит, менингококковый менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис), острые интоксикации и ототоксические препараты (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные препараты и другие), заболевания сердца и сосудов, в том числе нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне и нарушения реологических свойств крови, дегенеративные заболевания позвоночника с синдромом позвоночной артерии, а также моногенная наследственная патология и генетическая предрасположенность.

2.3 Степени тугоухости

Степень тугоухости определяется по усреднённому порогу слышимости воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
I степень	26–40 дБ

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
II степень	41–55 дБ
III степень	56–70 дБ
IV степень	71–90 дБ
Глухота	91 дБ и более

2.4 Другие классификации

По темпу развития различают внезапную тугоухость (снижение слуха в срок до 12 часов), острую (снижение развивается в течение 1–3 суток и сохраняется до месяца), подострую (снижение сохраняется 1–3 месяца) и хроническую, или стойкую (снижение сохраняется более 3 месяцев).

По времени возникновения тугоухость подразделяется на врождённую и приобретённую; по течению на стабильную, прогрессирующую, флюктуирующую и обратимую; по стороне поражения на одностороннюю и двустороннюю, симметричную или асимметричную; по этиологии на генетическую (наследственную), мультифакториальную (с наследственной предрасположенностью) и приобретённую.

2.5 Клиническая картина

Основными проявлениями сенсоневральной тугоухости у взрослых являются снижение слуха, ухудшение разборчивости речи, шум в ушах и ощущение заложенности ушей.

Ведущей жалобой является снижение слуха в сочетании с шумом в ухе, чаще постоянным, преимущественно смешанной тональности.

Для острой сенсоневральной тугоухости характерно внезапное одно- или двустороннее снижение слуха вплоть до глухоты. В ряде случаев (при острой травме, нарушении кровотока в лабиринтной артерии, токсическом поражении лабиринта) оно сопровождается шумом в ухе, а также острой вестибулярной и вегетативной дисфункцией: атаксией, головокружением, тошнотой, потливостью, тахикардией, колебаниями артериального давления, спонтанным нистагмом.

2.6 Жалобы и анамнез

Уточняются время возникновения и темп нарастания снижения слуха, различие слуха на правое и левое ухо, выраженность затруднений при общении. Активно выясняется наличие шума в ушах, его интенсивность и тональность, наличие вестибулярных нарушений и неврологической симптоматики.

При сборе анамнеза особое внимание уделяется состоянию слуха у ближайших родственников, характеру профессиональной деятельности, перенесённым инфекционным и соматическим заболеваниям, наблюдению у других специалистов.

Выявляются факторы риска: тугоухость у родственников (особенно при совпадении степени, формы и условий возникновения), работа в условиях производственного шума, приём ототоксических препаратов, перенесённые инфекционные заболевания (менингит, эпидемический паротит, корь, грипп и другие) и соматическая патология.

При острой тугоухости сбор анамнеза проводится по следующему плану: общее самочувствие и температура тела; на какое ухо снижен слух, когда и при каких обстоятельствах произошло снижение, изменялся ли слух в динамике, с чем пациент связывает его снижение, отмечалось ли снижение слуха ранее; наличие шума в ушах; наличие и характер головокружения (с определённым направлением или хаотичное), наличие тошноты, рвоты, диареи, потливости, уменьшение головокружения и шума после рвоты; приступы системного головокружения в анамнезе и установленный ранее диагноз болезни Меньера; отиты в анамнезе, принимаемые лекарственные препараты, уровень артериального давления.

Уточняется также наличие гипертонической, ишемической или цереброваскулярной болезни; травмы головы или шейного отдела позвоночника, интенсивного звукового воздействия, плавания или приёма ванны перед снижением слуха; слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушений чувствительности, движений и зрения; недавнего стоматологического лечения или протезирования зубов.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании жалоб на снижение слуха, шум в ушах и ухудшение разборчивости речи, нормальной отоскопической картины и аудиологических данных. При тимпанометрии регистрируется тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха регистрируются или отсутствуют. При тональной пороговой аудиометрии средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц составляет 26 дБ и более, костно-воздушный интервал не превышает 10 дБ. Результаты речевой аудиометрии соответствуют данным тональной аудиометрии.

3.1 Физикальное обследование

Необходимо убедиться в отсутствии изменений наружного и среднего уха. При сенсоневральной тугоухости отоскопическая картина без патологии: наружный слуховой проход свободный, барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая, опознавательные знаки чёткие.

Острая сенсоневральная тугоухость может развиться и у пациента с перенесённой или текущей патологией среднего уха, поэтому отоскопия необходима, однако для постановки диагноза и выбора тактики её недостаточно.

Проводится осмотр других ЛОР-органов для исключения заболеваний уха, носа и глотки, нарушающих воздушное звукопроведение.

3.2 Лабораторные исследования

Всем пациентам для оценки общего состояния показан общий (клинический) анализ крови.

При наличии соответствующей сопутствующей патологии исследуются липидный спектр (холестерин, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП)), биохимический общетерапевтический анализ крови (глюкоза, общий и прямой билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина), коагулограмма (активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), протромбиновое время, фибриноген) и уровень тиреотропного гормона.

3.3 Акуметрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ составляется слуховой паспорт: исследование слуха шёпотной и разговорной речью и камертональные пробы.

Акуметрия носит ориентировочный характер, однако на приёме оториноларинголога её достаточно для направления пациента к сурдологу-оториноларингологу.

3.4 Тональная пороговая аудиометрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ определяются пороги слышимости методом тональной аудиометрии: по воздушному звукопроведению на частотах 125–8000 Гц, по костному звукопроведению на частотах 250–6000 Гц. При нормальных порогах и наличии жалоб на снижение слуха или шум в ушах исследуется расширенный диапазон частот (125–20 000 Гц). Тональная аудиометрия является базовым методом как первичной диагностики, так и динамического наблюдения.

При внезапной и острой идиопатической потере слуха аудиометрия проводится не позднее суток от момента первого обращения. В ходе лечения, перед выпиской, исследование повторяется для регистрации восстановления порогов до нормы, их частичного восстановления или стабилизации (отсутствия дальнейшего прогрессирования) и определения дальнейшей тактики.

При хронической двусторонней тугоухости по данным аудиограммы определяются показания к слухопротезированию, традиционному или имплантационному, включая кохлеарную имплантацию, а при необходимости к направлению на медико-социальную экспертизу и составлению индивидуальной программы реабилитации. У пользователей слуховых аппаратов, аппаратов костной проводимости или кохлеарных имплантов оценивается эффективность слухопротезирования и при необходимости проводится его коррекция.

При асимметричном снижении слуха проводится маскировка лучше слышащего (неисследуемого) уха.

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводятся надпороговые тесты (определение порогов дискомфорта, тест SISI, тест Люшера) для выявления нарушения функции громкости (рекрутмент).

Исследование может быть дополнено сопоставлением порогов слышимости с порогами акустического рефлекса на частотах 500–4000 Гц.

3.5 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводится импедансометрия: тимпанометрия и регистрация акустического рефлекса ипси- и контралатерально. Исследование необходимо для исключения патологии среднего уха, дифференциальной диагностики сенсоневральной и кондуктивной тугоухости, выявления поражения слухового и лицевого нервов, центральных слуховых путей и ядер VII и VIII пар черепных нервов на уровне продолговатого мозга и моста.

Регистрация рефлекса в широком временном окне (до 10 секунд) позволяет выявить его распад, который является признаком ретрокохлеарного поражения.

Других типов тимпанограмм рекомендация не описывает: в критериях диагноза сенсоневральной тугоухости указана тимпанограмма типа «А», акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха могут регистрироваться или отсутствовать.

3.6 Речевая аудиометрия и объективные методы

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводится речевая аудиометрия в тишине и на фоне маскирующего шума.

Исследование позволяет определить пороги восприятия и разборчивость речи; речетональная диссоциация (несоответствие речевой и тональной аудиограмм) может указывать на центральные нарушения.

Для раннего выявления признаков эндолимфатического гидропса всем пациентам с подозрением на СНТ проводится электрокохлеография.

В амбулаторных условиях выполняется экстратимпанальная электрокохлеография с внутриушным электродом с регистрацией ответов на стимулы со сгущением и разрежением в начальной фазе.

Для дифференциальной и топической диагностики всем пациентам с подозрением на СНТ проводится исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП), вызванной отоакустической эмиссии и отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения.

При асимметричной тугоухости целесообразны предъявление стимулов низкой частоты и сравнение межпиковых интервалов I–V с обеих сторон.

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) представляет собой слабые звуковые колебания, генерируемые наружными волосковыми клетками улитки и регистрируемые зондом в наружном слуховом проходе. ОАЭ не регистрируется при порогах слышимости выше 25–30 дБ на частотах 1–4 кГц, охватывающих большую часть речевого диапазона.

КСВП отражают электрическую активность слухового пути в ответ на звуковой стимул и регистрируются с поверхности головы. Ответ представляет собой комплекс положительных пиков I–VII, наиболее стабильным из которых является V пик.

3.7 Интерпретация аудиограммы

Для периферического (кохлеарного) поражения характерна нисходящая аудиограмма без костно-воздушного разрыва с признаками феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНТ). При центральных (корковых и подкорковых) формах аудиограмма также чаще нисходящая, без костно-воздушного разрыва, однако ФУНТ отсутствует; при этом значительно нарушаются разборчивость речи в шуме и локализация звука.

3.8 Вестибулометрия и лучевые методы исследования

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводится вестибулометрия для оценки состояния преддверия и полукружных каналов, выявления дисфункции лабиринта и дифференциальной диагностики.

Для оценки анатомических структур всем пациентам с подозрением на СНТ выполняются магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, в том числе с внутривенным контрастированием (внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка), и компьютерная томография (КТ) височных костей высокого разрешения, в том числе с болюсным контрастированием. Особое значение эти методы имеют при односторонней и асимметричной тугоухости, однако они важны при любой степени и симметрии снижения слуха.

Отдельной рекомендацией предусмотрены рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и МРТ головного мозга, а при односторонней тугоухости МРТ с контрастным усилением для подтверждения или исключения невриномы слухового нерва.

МРТ позволяет уточнить дифференциальный и топический диагноз, уровень поражения слухового анализатора и анатомические особенности уха.

При наличии соответствующей сопутствующей патологии выполняются дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстра- и интракраниальных отделов) с цветным допплеровским картированием и триплексное сканирование вен.

3.9 Консультации и дифференциальная диагностика

При любом виде СНТ независимо от длительности заболевания показаны консультации терапевта, невролога и эндокринолога. При аутоиммунных заболеваниях и иммунодефицитных состояниях исследуется иммунный статус.

Выявление нарушений липидного и углеводного обмена позволяет обосновать патогенетическое лечение.

Дифференциальная диагностика проводится с другими причинами снижения слуха: лабиринтопатиями после хронического гнойного отита, радикальной операции на ухе или перенесённого лабиринтита, поражением внутреннего уха при инфекциях и интоксикациях, невриномой VIII нерва, нарушением кровообращения в вертебро-базилярном бассейне, рассеянным склерозом, объёмными образованиями головного мозга, черепно-мозговой и спинальной травмой, серной пробкой, сахарным диабетом, гипотиреозом, хронической почечной недостаточностью и другими состояниями.

На догоспитальном этапе диагноз острой сенсоневральной тугоухости является предположительным. Однако и предположительный диагноз требует экстренной защиты сенсорных структур внутреннего уха и срочной медицинской эвакуации в многопрофильный стационар с ЛОР-отделением для дифференциальной диагностики и лечения.

При подозрении на невриному слухового нерва или другое объёмное образование по данным МРТ или КТ показана консультация нейрохирурга.

4. Лечение и реабилитация

4.1 Внезапная и острая тугоухость

Пациент с диагнозом «острая сенсоневральная тугоухость» направляется на лечение в стационар или дневной стационар.

Показана экстренная госпитализация в оториноларингологическое или неврологическое отделение.

> В одном разделе рекомендации допускается лечение острой тугоухости в дневном стационаре, тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию в оториноларингологическое или неврологическое отделение.

Назначается охранительный слуховой режим.

Проводится внутривенная инфузионная терапия глюкокортикоидами по убывающей схеме с учётом сопутствующей патологии, противопоказаний и возможных побочных эффектов.

Глюкокортикоиды могут вводиться системно (внутрь или инфузионно) и местно (транстимпанально и транстубарно), возможно сочетание этих путей введения. В остром периоде сочетанное применение позволяет снизить системную дозу без потери эффективности.

При предположительно ишемическом генезе острой тугоухости на фоне сердечно-сосудистых нарушений внутривенно вводятся препараты для лечения заболеваний нервной системы, например #этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Препарат	Доза
#Дексаметазон	Внутривенно на 100 мл натрия хлорида: в 1-й и 2-й дни — 24 мг, в 3-й и 4-й — 16 мг, в 5-й — 8 мг, в 6-й — 4 мг, в 7-й день препарат не вводится, в 8-й — 4 мг.
#Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Раствор 5% — 4 мл на 16 мл натрия хлорида внутривенно, 8–10 дней.

4.2 Хроническая тугоухость

По индивидуальным показаниям с учётом соматической патологии проводятся поддерживающие курсы лечения.

Назначается охранительный слуховой режим.

Проводится лечение фоновой соматической патологии; 1–2 раза в год назначаются курсы поддерживающей терапии таблетированными препаратами, улучшающими мозговой и лабиринтный кровоток и тканевой обмен.

При некоторых формах хронической тугоухости (наследственной, постменингитной, ототоксической) лечение в отдалённом периоде неэффективно.

Если при острой тугоухости восстановление слуха на фоне лечения ещё возможно, то при хронической вероятность медикаментозного улучшения порогов крайне мала. Корректнее говорить о лечении сопутствующих сердечно-сосудистых, неврологических, эндокринных и иммунных нарушений, которое одновременно является профилактикой прогрессирования тугоухости. При вестибулярных нарушениях и ушном шуме проводится патогенетическое и симптоматическое лечение.

4.3 Слухопротезирование

Пациентам с хронической тугоухостью показаны подбор и настройка слуховых аппаратов при среднем пороге слышимости на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) на лучше слышащем ухе 31 дБ и более.

В алгоритме рекомендации уточнено, что пороги должны быть стабильными, а при выборе аппарата учитываются возраст, профессия, образовательные потребности и социальная активность пациента.

При невозможности использования слуховых аппаратов показана установка импланта среднего уха при условии, что пороги костного звукопроведения на частоте 500 Гц не превышают 55 дБ, на высоких частотах 75 дБ.

У пациентов со сниженным зрением и другими инвалидизирующими заболеваниями показания к слухопротезированию расширяются, а требования к техническим средствам реабилитации возрастают.

4.4 Кохлеарная имплантация

При двусторонней тугоухости IV степени или глухоте проводится слухоречевая реабилитация методом кохлеарной имплантации (КИ).

В настоящее время кохлеарная имплантация является единственным эффективным методом реабилитации при тугоухости высокой степени и глухоте и включает комплекс аудиологических, сурдопедагогических, психологических и хирургических мероприятий.

4.5 Показания к кохлеарной имплантации

№	Показание
1	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени с порогами слуха 80 дБ и более по данным КСВП
2	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени со средними порогами на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 80 дБ и более по данным тональной пороговой аудиометрии
3	Пороги в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами (бинаурально) выше 55 дБ на частотах 2–4 кГц
4	Отсутствие выраженного улучшения восприятия речи с оптимально подобранными слуховыми аппаратами при среднем пороге выше 95 дБ после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)
5	Разборчивость речи в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами менее 40% после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)

> Пороговые значения для кохлеарной имплантации в КР не согласованы с классификацией той же рекомендации. По разделу 1.5 IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как показания 1 и 2 касаются «IV степени с порогами 80 дБ и более», то есть охватывают и глухоту, но не всю IV степень. Показание 4 предусматривает средний порог выше 95 дБ, что соответствует глухоте, хотя речь в нём идёт о «высокой степени тугоухости».

Абсолютными противопоказаниями являются полная аплазия внутреннего уха (аномалия Мишеля), полная облитерация улитки, тяжёлые соматические, неврологические и психические заболевания, недостаточность интеллекта и отсутствие коммуникативных возможностей (исключения возможны для слабовидящих и слепых пациентов).

Относительными противопоказаниями являются отсутствие мотивации и возможностей для длительной реабилитации, частичная облитерация улитки, выраженные аномалии улитки и слухового нерва, обострение острых или хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов и ретрокохлеарная патология. При облитерации, аномалиях и ретрокохлеарной патологии решение принимает врачебная комиссия центра, выполняющего операцию.

Двусторонняя (бинауральная) имплантация выполняется одномоментно или последовательно. Она обеспечивает стимуляцию слуховых путей с обеих сторон, локализацию звука, лучшую разборчивость речи в шуме и при разговоре нескольких собеседников, более естественное и менее утомительное восприятие, а также сохранение слуха при поломке одного импланта.

Одномоментная бинауральная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени и глухоте после перенесённого менингита (при наличии выписки из стационара) по решению врачебной комиссии.

Последовательная бинауральная имплантация показана при оссификации или облитерации улитки после перелома височных костей и при отосклерозе, при аномалиях развития внутреннего уха, а также при хорошей динамике слуха и речи после односторонней имплантации и высокой мотивации; во всех случаях решение принимает врачебная комиссия центра. Объём последовательных имплантаций не должен превышать 10% годового объёма данного вида помощи в учреждении.

Противопоказания аналогичны противопоказаниям к кохлеарной имплантации; дополнительным противопоказанием является интервал между операциями, при котором система КИ используется с одной стороны более 5 лет.

Объём кохлеарной имплантации взрослым пациентам в учреждении не должен превышать 20% государственного задания по данному виду высокотехнологичной медицинской помощи. Гарантийный срок на имплант составляет не менее 10 лет, на речевой процессор не менее 5 лет.

4.6 Повторная имплантация

Причина	Тактика
Техническая неисправность импланта	Реимплантация
Гнойное воспаление среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика. При невозможности сохранения импланта показаны эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса импланта, исключающая использование речевого процессора, или экстракохлеарное положение электродной решётки	В таблице КР не заполнено

Реимплантация выполняется системой того же производителя; установка системы другого производителя возможна только за счёт внебюджетных средств, что отражается в информированном согласии.

При выходе импланта из строя в течение гарантийного срока производитель по заявлению медицинской организации в течение 10 суток предоставляет первичное заключение и в течение 30 суток после него предоставляет новый имплант. Неисправность окончательно устанавливается по результатам технической экспертизы извлечённого импланта, продолжительность которой не превышает трёх месяцев.

4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации

Пациентам с тугоухостью и шумом в ушах проводится электростимуляция.

Применяются постоянный импульсный ток прямоугольной формы и флюктуирующие токи силой 0,5–2 мА; частота подбирается в соответствии с частотой шума. Продолжительность процедуры 10–15 минут, курс 10–15 процедур. Метод противопоказан пользователям кохлеарного, стволомозгового импланта и импланта среднего уха.

Проводится курс гипербарической оксигенации: 10–20 процедур при давлении 1,5–2,5 атм продолжительностью 1–2 часа.

Лечение предпочтительно начинать в течение первого месяца от начала заболевания; результаты лучше при сочетании с глюкокортикоидами.

В курс лечения включается рефлексотерапия.

Метод эффективен в качестве дополнительного лечения, в том числе на поздней стадии; электропунктура эффективнее классической иглорефлексотерапии. Используются импульсы длительностью 1 мс переменной полярности частотой 61 Гц, амплитуда до ощущения лёгкого покалывания, по 10 минут на пару точек; курс 10–15 процедур ежедневно или через день.

Проводится электронейростимуляция головного мозга.

Наибольшая эффективность отмечается при начальной и лёгкой степени тугоухости, в том числе при аудиоселективной транскраниальной электростимуляции: сила тока до 1,0 мА, продолжительность 20 минут, 15 процедур через день. Метод противопоказан пользователям имплантов.

В курс лечения включаются дозированные физические нагрузки.

Используются баланстерапия и дыхательная гимнастика курсами по 3 месяца, 3 раза в неделю по 40 минут, а также ежедневный терренкур продолжительностью не менее 20 минут.

Проводится транскраниальная магнитная стимуляция, в том числе при шуме в ушах на фоне тугоухости.

Выполняется ритмическая стимуляция височно-теменных, лобных и префронтальных областей коры. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Применяются лекарственный ультрафонофорез и внутриушной электрофорез лекарственных препаратов.

В наружный слуховой проход вводится 1,5–2,0 мл лекарственного препарата, нагретого до 36–37 °C. Продолжительность процедуры 5–15 минут при частоте 880 кГц, мощности до 0,2 Вт/см² и гальваническом токе до 0,3 мА; курс 10–12 процедур. Метод противопоказан пользователям имплантов.

В курс лечения включается медицинский массаж.

Выполняется лечебный массаж шеи и воротниковой зоны (классический, точечный или вакуумный) ежедневно, курсом до 10 процедур.

В комплексной терапии применяется лазеротерапия.

Внутривенное лазерное облучение крови сочетается с введением трентала: длина волны 630 нм, мощность 1,0–2,0 мВт, продолжительность 25–30 минут, 5–7 процедур ежедневно. При эндауральной методике длина волны составляет 808–810 нм, плотность потока 8–15 мВт/см², продолжительность 8–10 минут, 12–14 процедур ежедневно.

В курс лечения включается слуховой тренинг в виртуальной реальности.

Метод показан в качестве дополнительного при хронической тугоухости лёгкой степени и скрытой потере слуха: ежедневно в течение 7 дней по 15 минут с одной паузой продолжительностью 2 минуты.

Проводятся вестибулярные тренировки, в том числе в виртуальной реальности.

Тренировки равновесия проводятся ежедневно или через день по 30 минут, курс 20 процедур.

Для улучшения слуха, в том числе после кохлеарной имплантации, используются мобильные приложения с шумоподавлением в режиме реального времени.

Методы, перечисленные в пунктах 4–15 раздела реабилитации, как правило, применяются в ходе санаторно-курортного лечения после консультации врача.

4.8 Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение проводится в хронической стадии тугоухости, врождённой или приобретённой; в таблице КР перечислены все степени, от I до глухоты.

Код	Заболевание
H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя
H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточнённая

Показаны бальнеологические курорты с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми и йодобромными водами, климатические (приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные) и грязевые курорты.

При неэффективности как слуховых аппаратов, так и кохлеарных имплантов необходим альтернативный способ коммуникации: обучение дактилю и жестовому языку, сурдоперевод.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с хронической тугоухостью подлежат диспансерному наблюдению у сурдолога-оториноларинголога в сурдологическом кабинете или центре по месту жительства с оценкой эффективности лечения и состояния пациента.

Эффективность слуховых аппаратов оценивается по данным речевой аудиометрии в свободном звуковом поле в тишине и в шуме и анкетирования о качестве жизни. Тональная аудиометрия, речевая аудиометрия в тишине и в шуме и коррекция настроек слухового аппарата по их результатам проводятся 1–2 раза в год.

При остром ухудшении или быстром прогрессировании тугоухости исследование повторяется незамедлительно для своевременного проведения лечения и восстановления порогов.

После кохлеарной имплантации речевая аудиометрия в свободном звуковом поле в тишине и в шуме проводится после подключения речевого процессора и на каждой настроечной сессии, 2–4 раза в год, в сочетании с анкетированием. Тональная и речевая аудиометрия повторяются 1–2 раза в год, настройка речевого процессора проводится 2–4 раза в год.

Для оценки эффективности слуховых аппаратов в рекомендации приведён опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов» из 7 вопросов. Если во всех вопросах выбраны ответы 1 и 2, необходимы коррекция настроек, повторное обследование слуха и направление пациента на слухоречевую реабилитацию; если во всех вопросах выбран вариант 3, требуется коррекция настроек; при вариантах 4 и 5 изменение настроек не требуется.

При односторонней тугоухости необходима дополнительная дифференциальная диагностика, при вестибулярных нарушениях и ушном шуме требуются дополнительные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.

По показаниям пациент направляется на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о стойкой нетрудоспособности. Одновременно с установлением группы инвалидности составляется индивидуальная программа реабилитации с указанием выбранного способа коррекции слуха: традиционного или имплантационного слухопротезирования либо кохлеарной имплантации.

5.1 Показания к госпитализации

Показаниями к госпитализации являются острая сенсоневральная тугоухость и замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации (в круглосуточном или дневном стационаре).

Выписка осуществляется при выздоровлении или улучшении состояния.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у взрослых»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 22.03.2023 (год утверждения в PDF не заполнен: «20__»)
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года; следующая версия ожидалась не позднее марта 2026 года, но на 22.10.2026 в рубрикаторе действует эта
Код в рубрикаторе	518_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Пороги для кохлеарной имплантации не согласованы с классификацией: IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как в показаниях указаны «IV степень с порогами 80 дБ и более» и средний порог «более 95 дБ» (по классификации это соответствует глухоте).
- В разделе 3.1 пациент с острой тугоухостью направляется «в стационар или дневной стационар», тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию.
- В рекомендации о слуховых аппаратах речевые частоты указаны как «500, 1000, 2000 и 4000 кГц», тогда как должно быть «Гц».
- В таблице реимплантации у строки «Миграция корпуса внутренней части кохлеарного импланта…» не заполнена графа «Методы лечения».
- Одна и та же рекомендация об охранительном слуховом режиме при острой тугоухости имеет УДД 5, при хронической УДД 4.
- МРТ головного мозга рекомендована дважды, отдельными рекомендациями с разным объёмом (во второй вместе с рентгенографией шейного отдела позвоночника).
- В схеме #дексаметазона на 7-й день препарат не вводится, а на 8-й день вновь вводится 4 мг; так указано в тексте КР.
- Год утверждения на титульном листе не заполнен («20__»); PDF представляет собой скан с распознанным текстом и содержит много ошибок распознавания (например, «8181» вместо SISI, «1рз1 и соШга» вместо ipsi и contra).